Hôpital Paris Saint-Joseph

# MEDI MEMO IOA

SERVICE DES URGENCES

ANNEE 2026

MR G. SILVETTI

IOA 3

MISSIONS
DEROULEMENT
ENTRETIEN
TRI

GRILLE DE TRI 8

ROUGE
ORANGE
JAUNE
ROSE
VIOLET
BLEU
VERT

AIDE MEMO 16

MALAISE
DOULEUR THORACIQUE
AVC / AIT
DOULEUR ABDOMINALE
DYSPNEE / D.R.A
CRISME D'ASTHME
VERTIGES
SAIGNEMENTS
TRAUMATISME CRÂNIEN
TRAUMATISME
PLAIE
AVP
DEXTRO / CETONEMIE
CEPHALEE

BRÛLURES 31

FONCTION VITALES
EVALUATION

SCORES 35

QSOFA
FTPA

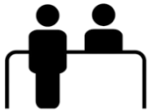
PROTOCOLES 38

DEMANDE ANTICIPEE DE
RADIOGRAPHIE
DELIVRANCE
D'ANTALGIQUE
ELECTROCARDIOGRAMME

# IOA

# MISSIONS

1



Accueillir
Evaluer
Tri

2



Décider
du lieu
de soins
adapté

3



Installer

4



Informer

5



Surveiller

6



Anticiper

7



Communiquer
Coordonnée

8



Enseigner

# DEROULEMENT

1 → 2 → 3 → 4

## Accueil

Présentation (prénom, fonction, intérêt de l'évaluation, variation ordre de passage : temps d'attente environ)

 **information indispensable**
=
acceptation de l'attente
+ diminution de l'anxiété.

=
Soins relationnel, relation de confiance.

## Analyse

Examen clinique infirmier :

Examen physique
(5 sens – Ø goût).
Vue
Toucher
Odorat
Ouïe

## Entretien

Entretien : 3Q2C
Qui ?
Quoi ?
Quand ?
Comment ?
Combien ?

Paramètres vitaux :
FC
TA
SpO2
FR
Température
Douleur
Glasgow et/ou conscience

## Décision

Décision du niveau de tri & choix de la zone de soins en fonction des éléments recueilli et des critères de gravité ou non du patient

→ Grille de tri

# ENTRETIEN

## 3Q2C

**QUI**

Age
Sexe
ATCD
épisodes similaires
TTT Spécifiques

**QUAND**

Date et heure de début

**QUOI**

Motif (attention peut être différent à l'arrivée)

**COMMENT**

Facteurs déclenchants, circonstances, mode de début et d'évolution

**COMBIEN**

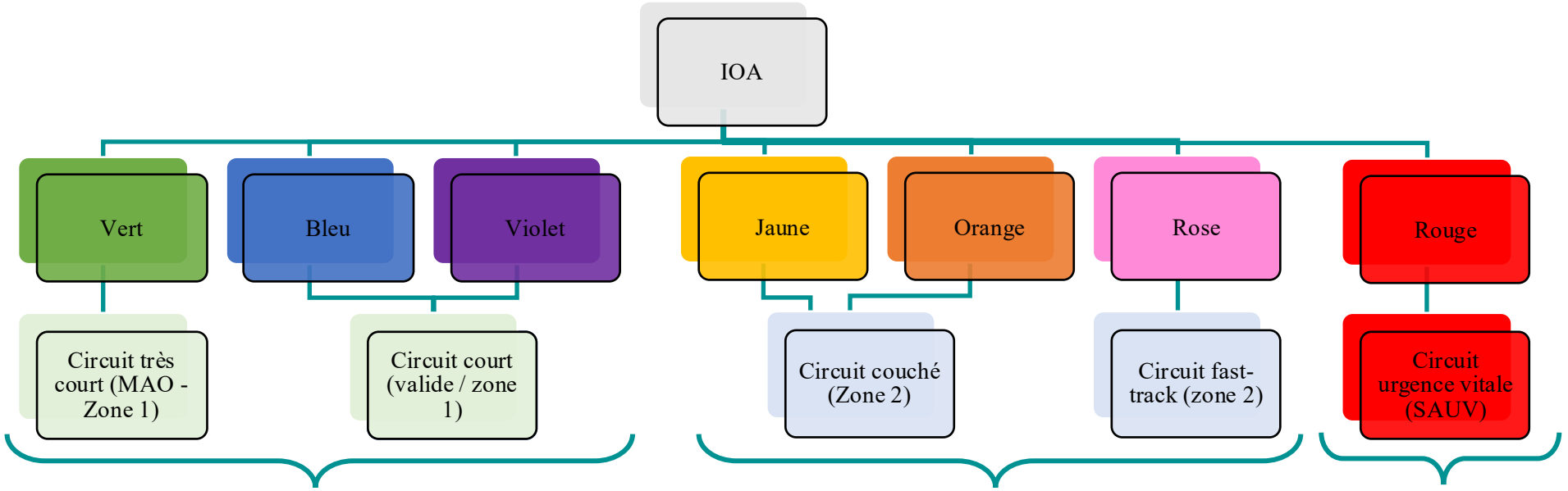
Intensité du symptômes, pics, évolution

Me W, 31 ans.

Patiente vient pour douleurs au niveau de l'hypochondre droit.
Douleur d'apparition brutale ce jour vers 18h, avec nausées sans vomissements.
Pas de SFU, pas de troubles du transit associés.
DDR : Il y a 2 semaines, patiente sous contraception et pas de risque de grossesse.

A l'IOA, douleurs présente, intensifié à la palpation, sans irradiation.
Abdomen souple.
Présente des nausées.

# LE TRI A SAINT-JO




## Zone Valide = Zone 1

*Violet*

*Prise en charge immédiate*

*Bleu*

*Prise en charge médicale.*

*Vert*

*Circuit particulier – PEC 1H30 début/fin.*

## Zone couchée = Zone 2

*Orange*

*Prise en charge médicale < 60 min*

*Jaune*

*Prise en charge médicale < 90 min*

*Rose*

*Fast Track (prise en médicale < 60 min + PEC dans le service < 2h)*

## SAUV

*Rouge*

*Prise en charge immédiate*

# GRILLE DE TRI

# ROUGE

*PATIENT PRESENTANT UNE DETRESSE OU UNE PATHOLOGIE NECESSITANT UNE INSTALLATION IMMEDIATE*

## CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE

ACR

Tas < 80mmHg et/ou Signes périphériques de choc (marbrures - cyanose des extrémités)

FC > 140 avec ECG et après avis MAO ou FC < 45

Douleur thoracique avec modification ECG TAS > 220mmHg symptomatique

Patient présentant un QSofa > ou = 2 critères.

## RESPIRATOIRE

FR < 8

SpO2 < 94% sous 6L/min d'O2 ET FR > 22

Hémoptysie active ou hémoptysie avec SAT < 94%

Détresse respiratoire haute (laryngée) ou CE avec hyper sialorrhée

## NEUROLOGIQUE

Coma avec score de Glasgow < 9

Déficit neurologique < 4h30 (même si constaté au réveil)

## DIGESTIF

Hémorragie digestive active : hématémèse – méléna – rectorragies très abondantes (avec défaillance hémodynamique)

## INFECTIOLOGIE

Hypothermie avec modification ECG

## INTOXICATION *quelle que soit la nature*

Avec modification ECG

## MÉTABOLIQUE

Hyperglycémie (dextro = HI) avec cétonémie > 1,5 OU Hypoglycémie avec dextro ≤ 0.3

Hyperkaliémie > 6 mmol/L avec modification ECG OU Hypokaliémie < 2,5 même sans modification ECG

## TRAUMATOLOGIE

Amputation de membre complète ou quasi complète (sauf doigts et orteil)

Plaie artérielle évidente/ou garrot mis en place

Brûlures : étendues (> 10% SC) et/ou circulaire AVEC antalgie par anesthésie vigile ou siège particulier : ORL / Tête / Périnée

Traumatisme pénétrant (arme blanche ou arme à feu) du thorax ou abdomen ou crânien ou cervical

Electrisation ou électrocution avec modification ECG après accord MAO

## PÉDIATRIE : SAU sans activité pédiatrique

ACR / Coma

# ORANGE

*PATIENT ALITE PRESENTANT UNE CONSTANTE D'ALERTE OU UNE PATHOLOGIE POTENTIELLEMENT GRAVE ET/OU URGENTE*

## CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE

**Syncope sans prodromes *(À SCOPER)***

**Douleur thoracique typique persistante sans trouble de la repolarisation à l'ECG *(À SCOPER)***

## RESPIRATOIRE

**SpO2 < 94% sous O2 < 6L/min ET FR > 22 *(À SCOPER)***

## NEUROLOGIQUE

Troubles de la conscience avec score de Glasgow 9 – 14

**> 2 crises épilepsie dans l'heure (non épileptique connu) *(À SCOPER)***

## INTOXICATION *quelle que soit la nature*

Glasgow < 15 et > 9

## MÉTABOLIQUE

Hypoglycémie avec score de Glasgow de 14 ou 15

**Hyperkaliémie > 6 mmol/L *(À SCOPER)***

## TRAUMATOLOGIE

Brûlures : étendues (> 10% SC) SANS antalgie par anesthésie vigile ou SANS siège particulier : ORL – tête – périnée (non circulaire)

Plaie du scalp de grande taille très hémorragique après accord du MAO

## DOULEUR

EN > 7 pour titration en morphine → Avec transmissions orales (IDE/MEDECIN)

EN entre 5 et 7 nécessitant la prise d'Actickenan Oro®

# JAUNE

*PATIENT ALITE MAIS NE PRESENTANT PAS NI SIGNE DE GRAVITE, NI D'URGENCE*

# ROSE

*PATIENT STABLE SUR LE PLAN HEMODYNAMIQUE, MONOMOTIF, NECESSITANT D'ETRE ALLONGE*

Rétention aigue d'urine

**Douleur de la fosses lombaires hyperalgiques non fébrile (hors 1er épisode + de 60 ans).**

**Douleur des OGE de plus de 24h, non brutale.**

**Déficit neurologique (moteur, sensitif, sensoriel ou du langage) + de 6h et – de 24h (Appel IDE Zone 2B)**

Problème de matériel médical

Mono traumatisme de membre hors tronc

Traumatisme **bassin/hanche** ne pouvant pas être en zone valide.

**TC sans signe** de focalisation de la personne non valide **(pas de prise d'anticoagulant).**

Patient adressé pour réalisation d'un Angioscanner devant des **Ddimères augmentés.**

**Crise convulsive** résolutive d'un patient **épileptique connu**

**Anémie sans autres anomalies** (paramètres vitaux stable + pas de saignement extériorisé)

**Erythème et/ou œdème d'un membre isolé, hors anaphylaxie.**

**Plaie non traumatique (ulcères MI, escarres hors stade IV).**

**Plaie superficielle hors main, ou zones à risque du visage.**

Ebriété sur la voie publique, **Glasgow 14 et/ou somnolent mais réveillable.**

IMV du sujet non délirant, **Glasgow 15 (non agité et sans ATCD psychiatrique).**

Epistaxis **non traumatique** avec stabilité hémodynamique

**Douleur abdominale isolée du sujet de moins de 50 ans, sans ATCD ou comorbidité.**

**Douleur thoracique atypique du sujet de moins de 50 ans, sans ATCD ou comorbidité.**

**Douleur articulaire, de membre, sciatique et ou rachidienne sans fièvre.**

**HTA non symptomatique (suppression dans le tri orange de TAS > 22 mmHg asymptomatique)**

**Membre chaud, douloureux, OMI.**

**FTPA (seulement si correspond aux critères suivants) :**

**+ de 75 ans, sans problème sociaux**

**Motif de consultation simple et/ou chutes à répétitions.**

# VIOLET

*PATIENT VALIDE PRESENTANT UN DES MOTIFS SUIVANTS :*

Crise d'asthme
Eruption cutanée supposée allergique récente et évolutive Douleur des organes génitaux externe (OGE).
Patient arrivant pour un **problème psychiatrique (sans problème somatique) ou CPU psychiatrique.**
Patient arrivant avec un **diagnostic chirurgical avéré**
Patient adressé des **urgences gynécologiques**
Patient reconvoqué par les urgences nécessitant des examens complémentaires (bilan sang, imagerie, un avis spécialisé ou une hospitalisation)
**Patient(e) victime de violences conjugales (installation en box)**

# MARRON

*PATIENT PRESENTANT UNE PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE NE NECESSITANT PAS D'AVIS SOMATIQUE*

Consultation Post-urgences (CPU) de Psychiatrie
Patient arrivant pour un problème psychiatrique (sans problème somatique et sans besoin d'évaluation somatique a priori)

# BLEU

*PATIENT VALIDE NE PRESENTANT NI SIGNE DE GRAVITE, NI D'URGENCE*

Plaies
Trauma des extrémités avec fracture ou signes cliniques de fracture (déformation)
Patient nécessitant un bilan sang et/ou un examen d'imagerie (TDM, Echo)

# VERT

*PATIENT VALIDE PRESENTANT UN DES MOTIFS SUIVANT :*

Traumatisme simple des extrémités (non fracturé) avec prescription de radios anticipées AES
CNA
Panaris collecté isolé
Consultation simple ne pouvant être réorientée

# AIDE MEMO

# MALAISE

## Dois figurer dans votre IOA

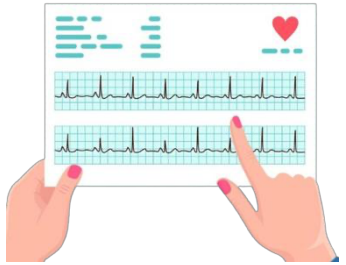
**AVEC** prodromes : vertiges, douleur, nausées, bourdonnements d'oreilles...

**SANS** prodromes = **SYNCOPE** = Scope

AUTRES : TC, PC, Douleur thoracique

## SOINS PARTICULIERS

ECG
POUR TOUS



+

HGT



# DOULEUR THORACIQUE

## Dois figurer dans votre IOA

**HEURE DE DEBUT**

**LOCALISATION**

**TYPE** : pique, pince, serre, brûle...

**IRRADIATION** : bras, mâchoire, dos...

**ARRIVEE** : au repos, à l'effort

**APPARITION :** Progressive / Brutale

**PRESENTE A L'IOA OU NON ?**

**CONTINUE OU DISCONTINUE**

**DYSPNEE ASSOCIEE**

**FACTEURS DE RISQUES :**

Tabac, Cholestérol, HTA, Diabète, Dyslipidémie, Surpoids

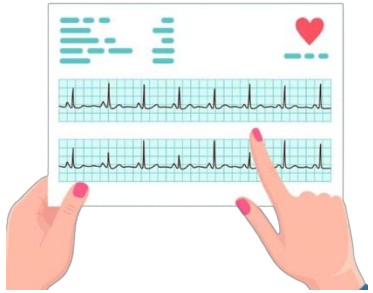
**ATCD familiaux :**

IDM < 60ans

## SOINS PARTICULIERS

ECG

POUR TOUS



+

TENSION ARTERIELLE

Aux 2 bras



# AVC / AIT

## Dois figurer dans votre IOA

**HEURE DE DEBUT**

**SYMPTÔMES**

Déficit moteur et/ou sensitif



Troubles du langage



Troubles de la vision



Pupilles symétriques et réactives



Vertiges (types)



**LA CONFUSION N'EST PAS SIGNE D'UN AVC**

**DEFICIT < 4h30**
**=**
**ALERTE THROMBOLYSE**
**=**
**ROUGE**

**DEFICIT > 6h & < 24h**
**=**
**NIHSS (dans l'heure)**
**=**
**ROSE**

## SOINS PARTICULIERS

DECUBITUS

0° strict



+

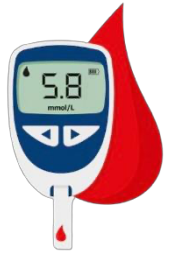
TENSION ARTERIELLE

Aux 2 bras



+

HGT



# DOULEUR ABDOMINALE

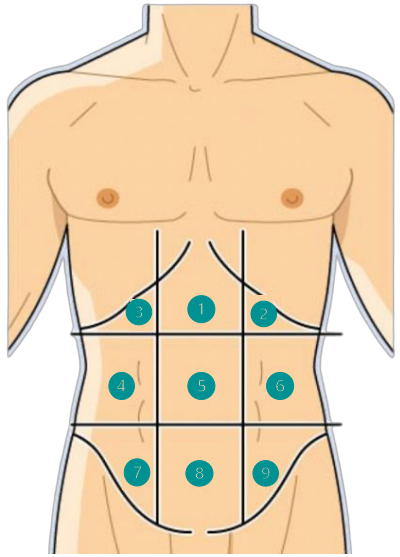
## Dois figurer dans votre IOA

**SFU** (signes fonctionnels urinaires) : Brûlures mictionnelles, hématurie

**TRANSIT** : Gaz ? Selles ? Diarrhée ?

**AUTRES** : Abdomen souple, distendu ? Douloureux à la palpation
Nausées / Vomissements (type ?)
Irradiation lombaire

**LOCALISATION** :

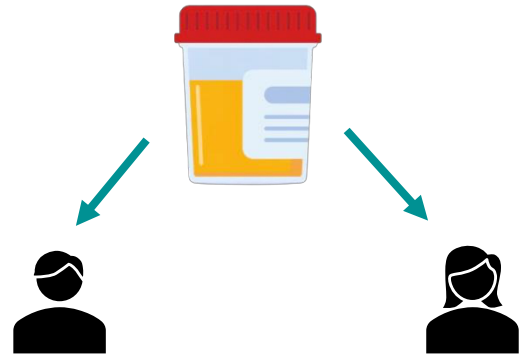



1. Epigastre
2. Hypochondre Gauche
3. Hypochondre Droit
4. Flanc Gauche
5. Région périombilicale
6. Flanc Droit
7. Fosse iliaque Droite
8. Hypogastre
9. Fosse iliaque Gauche

\+ **FEMME**
Date des dernières règles
Moyen de contraception
Risque de grossesse

## SOINS PARTICULIERS

BANDELETTE URINAIRE



HOMME

FEMME
*Seulement si SFU*

# DYSPNEE / D.R.A

## Dois figurer dans votre IOA

### SIGNES CLINIQUES

Signes de lutte respiratoire : Tirage, balancement thoraco-abdominal, polypnée, bradypnée

Autres signes : Marbrures, difficultés à la parole, cyanose, sueur, douleur thoracique associée...

ATCD : BPCO (SpO2 de base), Asthme (DEP)

**DYSPNEE = SENSATION D'UNE RESPIRATION DIFFICILE ET INCONFORTABLE RESSENTIE DANS UNE SITUATION QUI NORMALEMENT N'ENTRAÎNE AUCUNE GÊNE RESPIRATOIRE**

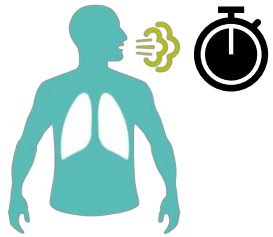
## SOINS PARTICULIERS

POSITION DEMI-ASSISE



+

FREQUENCE RESPIRATOIRE



+

SpO2



# CRISME D'ASTHME

## Dois figurer dans votre IOA

**NOMBRE DE CRISES**

**HEURE DE DEBUT → DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ?**

**OBSERVANCE DU TRAITEMENT**

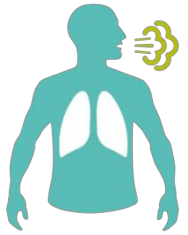
**DIFFICULTES A LA PAROLE : TEST DES 10 SECONDES**

**Signes de lutte respiratoire :** Tirage, balancement thoraco-abdominal, polypnée, bradypnée

**ATCD :** Hospitalisation en réanimation = critère de gravité !

## SOINS PARTICULIERS

FREQUENCE RESPIRATOIRE



+

SpO2



+

PEAK FLOW (DEP)



# VERTIGES

## Dois figurer dans votre IOA

**HEURE DE DEBUT**

**ELIMINER UN AVC/AIT**

**APPEL MAO SI VERTIGES < 4h30**

**TYPES :**

- **ROTATOIRE**
- **QUI TANGUENT**

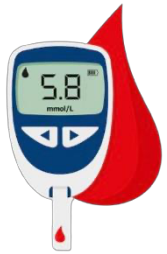
- **POSITIONNELS**
- **NON POSITIONNELS**

**NAUSEES / VOMISSEMENTS**

**VERTIGES POST TRAUMATISME CRÂNIEN ?**

## SOINS PARTICULIERS

HGT



# SAIGNEMENTS

## Dois figurer dans votre IOA

### LOCALISATION

- **SELLES = MELENA**
- **URINES = HEMATURIE**
- **VOMISSEMENT = HEMATEMESE**
- **CRACHAT = HEMOPTYSIE**

### QUANTITE

- **TRACE**
- **½ VERRE**
- **1 VERRE**

### ACTIF OU NON

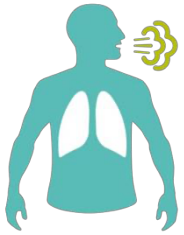
### DUREE

### AVEC OU SANS ATC / AAP

### SIGNES ASSOCIES : Marbrures / DRA / Pâleur ...

## SOINS PARTICULIERS

FREQUENCE RESPIRATOIRE



+

SpO2



+

HEMOCUE



# TRAUMATISME CRÂNIEN

## Dois figurer dans votre IOA

### SIGNES CLINIQUES :

- **PERTE DE CONNAISSANCE (DUREE)**
- **NAUSEES / VOMISSEMENTS**
- **VERTIGES**
- **TROUBLES DE LA VISION**
- **SIGNES NEUROLOGIQUES**
- **ATC / AAP**

| 9-TRAUMA CRANIEN | 10-TRAUMA |
|---|---|
| Signes cliniques : Perte de connaissance (durée), nausées/vomissements, vertiges, troubles de la vision, signes neurologiques, ATC/AAP<br>Soin particulier : Glasgow | Signes cliniques : Déformation, raccourcissement de membre, plaie ouverte, mobilité, sensibilité, pouls du membre en aval, couleur, chaleur |
| **11-PLAIE** | **12-AVP** |
| Localisation, suturale, taille, saignement actif, depuis combien de temps, mobilité, sensibilité, allure (écoulement, corps étranger…), **VAT**<br>Soins particulier : détersion, pansement humide provisoire, xylocaïne | Cinétique (vitesse), ceinture, airbag déclenché, casqué, état du véhicule et du casque, PC initiale, amnésie des faits, TC, surveillance trauma abdominale et thoracique, douleur rachis, signes neurologiques<br>Soins particuliers : Hemocue, BU si nécessaire |
| **13-DEXTRO** | **14-CETONEMIE** |
| Pour tout patient si : vertiges, vomissements, malaise, diabétique, convulsions, troubles neurologiques, troubles du comportement | Pour tout dextro supérieur à 3g |

## SOINS PARTICULIERS

HGT




+

GLASGOW



# TRAUMATISME

## Dois figurer dans votre IOA

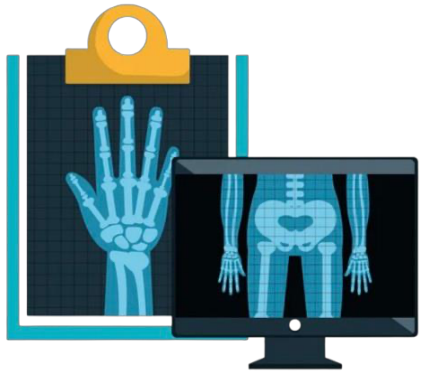
### SIGNES CLINIQUES :

- **DEFORMATION**
- **RACCOURCISSEMENT DU MEMBRE**
- **PLAIE OUVERTE**
- **MOBILITE**
- **SENSIBILITE**
- **POULS DU MEMBRE EN AVAL**
- **COULEUR**
- **CHALEUR**

### TRC (TEMPS DE RECOLORATION CUTANEE)

## SOINS PARTICULIERS

PROTOCOLE
« DEMANDE ANTICIPEE
DE
RADIOGRAPHIE »



# PLAIE

## Dois figurer dans votre IOA

**LOCALISATION**

**SUTURABLE OU NON**

**TAILLE (CM ENVIRON)**

**SAIGNEMENT ACTIF OU NON**

**HEURE DE DEBUT → DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ?**

**MOBILITE / SENSIBILITE**

**ALLURE**

- ☐ **DELABRANTE**
- ☐ **LARGE**
- ☐ **COMPLEXE**
- ☐ **SOUILLEE**
- ☐ **SUPERFICIELLE**
- ☐ **DERMABRASION**

**ECOULEMENT**

- ☐ **EN NAPPE**
- ☐ **EN JET**

**VACCIN ANTI-TETANIQUE A JOUR ?**

## SOINS PARTICULIERS

DETERSION
(eau + savon)



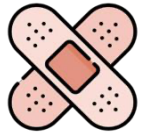
+

XYLOCAÏNE
SPRAY



+

PANSEMENT HUMIDE
PROVISOIRE



# AVP

## Dois figurer dans votre IOA

**CINETIQUE (VITESSE)**

**CEINTURE ?**

**AIRBAG DECLECHE ?**

**CASQUE ?**

**ETAT DU VEHICULE ET DU CASQUE**

**PERTE DE CONNAISSANCE INITIALE**

**AMNESIE DES FAITS**

**SURVEILLANCE TRAUMA ABDO / THO**

**DOULEUR RACHIS / CERVICAL**

**SIGNES NEUROLOGIQUES**

## SOINS PARTICULIERS

HEMOCUE



+

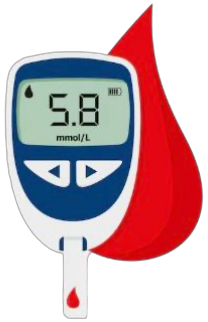
BANDELETTE URINAIRE



(Seulement si nécessaire)

# DEXTRO / CETONEMIE

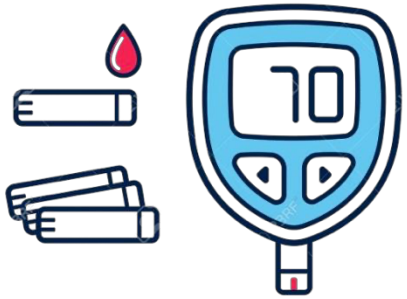
**DEXTRO (HGT)**
**POUR**




- **VERTIGES**
- **VOMISSEMENTS**
- **MALAISE**
- **DIABETIQUE**
- **CONVULSIONS**
- **TROUBLE NEUROLOGIQUES**
- **TRAUMATISME CRÂNIEN**
- **TROUBLES DU COMPORTEMENT**

**HGT > 3g**

**CETONEMIE**



# CEPHALEE

## Dois figurer dans votre IOA

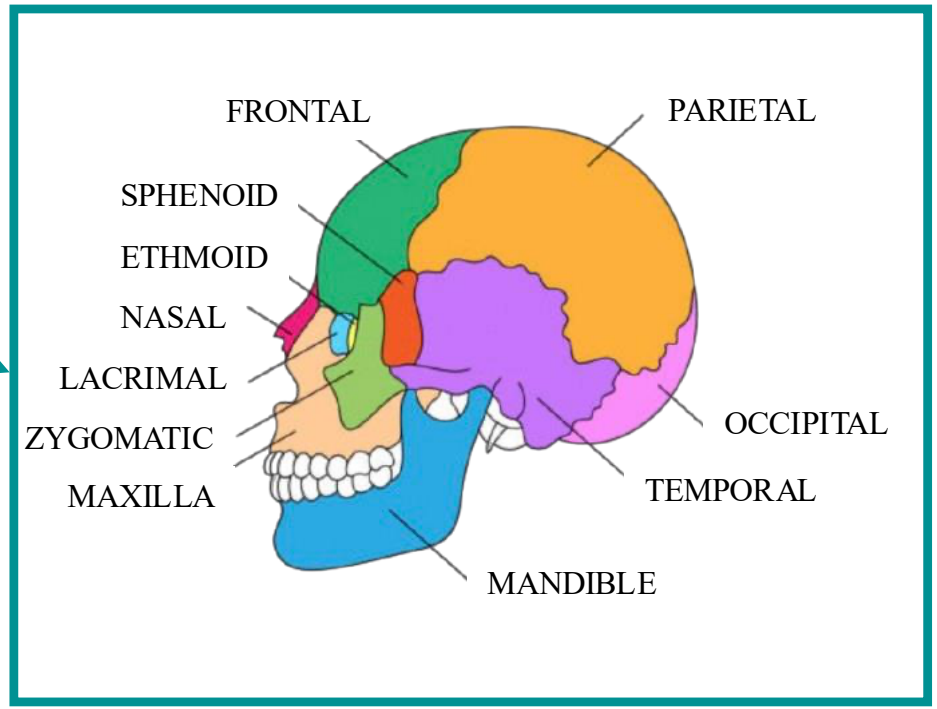
**SIEGE**

**INSTALLATION**

- **BRUTALE (« coup de tonnerre »)**
- **PROGRESSIVE**

**TYPE**

- **PULSATILE**
- **CONTINUE**



# BRÛLURES

## THERMIQUE

*90%*

Les plus courantes. elles sont liées à un contact avec un liquide brûlant ou avec des flammes.

## CHIMIQUE

*3 à 5%*

Les brûlures chimiques sont dues à la réaction des tissus en contact avec des substances nocives, comme les nettoyants industriels, les solvants, le pétrole…

## ELECTRIQUE

*5 à 7%*

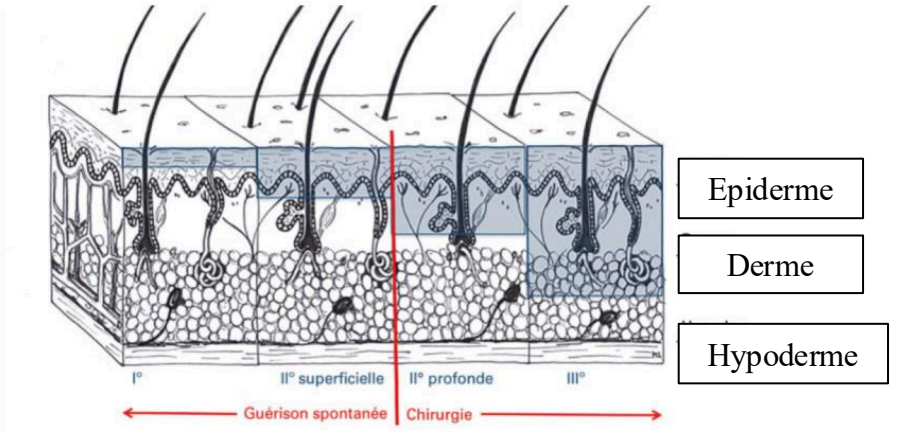
Les brûlures électriques sont toujours graves.

Domestic : 220 V
Haute tension : 1000 V

## CLIMATIQUE

Causée par le changement de température extrême. Les extrémités du corps sont les plus touchées.
Deux types :
Crevasses et gerçures *(dues à une déshydratation due au froid).*
Engelures *(atteinte de la peau sans déshydratation).*

# ANATOMIE



# EVALUATION

1

## FONCTIONS VITALES

ABECEDAIRE DE L'URGENCE VITALE

### A



**AIRWAYS**

Libération des voies ariennes & protection du rachis cervical

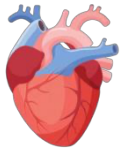
### B



**BREATHING**

Respiration & ventilation

### C



**CIRCULATION**

Contrôle de l'hémorragie & de l'état hémodynamique

### D



**DISABILITY**

Etat neurologique

### E



**ENVIRONNEMENT**

Domicile, travail, extérieur, ....

# EVALUATION

2

## EVALUATION DE LA BRÛLURE

| S | P | L | T | C |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| **SURFACE** | **PROFONDEUR** | **LOCALISATION** | **TERRAIN** | **CIRCONSTANCES** |
| Evaluation de la surface brûlée. Règle des 9 de Wallace | Reconnaître le degré de brûlure – 2ème & 3ème degré (1er = Erythème) | Gravité en fonction de la zone. Visage, mains, pied et périnée = Urgences Vitales | Antécédents médicaux ; Âge ; Comorbidités (OH, Athérome, Diabète, Immunosuppression, Ins. Cardiaque). | Agents causals : Electrique Chimique Thermique Climatique |

# SCORE

# QSOFA

1



ALTERATION DE L'ETAT DE CONSCIENCE

**GCS < 15**

2



PRESSION ARTERIELLE SYSTOLIQUE

**PAS < 100**

3



FREQUENCE RESPIRATOIRE

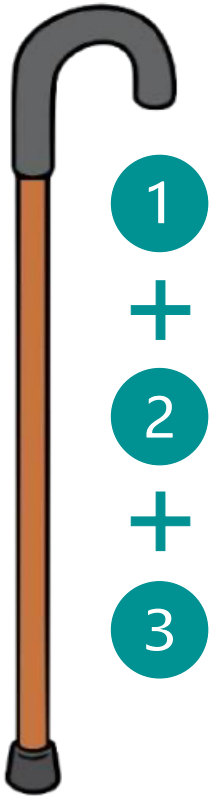
**FR > 22/min**



**QSOFA > 2 CRITERES → SAUV**

# FTPA





1 ÂGE > 75 ans

+

2 PAS DE PROBLEMES SOCIAUX

+

3 MOTIF SIMPLE / CHUTES A REPETITIONS

# PROTOCOLES

# PROTOCOLE DEMANDE ANTICIPEE RADIOGRAPHIE



## Inclusion

- 16 ans et + ayant été informé du protocole
- Patient consultant pour un traumatisme simple et isolé du membre supérieur ou du membre inferieur et n'ayant aucune radiographie antérieure pour le même traumatisme.
- PEC adéquate de la douleur
- Faisabilité : patient coopérant, inspection facile.



## Exclusion

- Patient n'ayant pas consenti au protocole
- Douleur non traumatique
- Traumatismes multiples ou signes clinique évoquant des traumatismes multiples
- Circonstances non mécaniques du traumatisme (ex : malaise, syncope, épilepsie) ayant provoqué une chute
- Accident à forte cinétique
- Signes évocateurs d'une fracture ouverte : plaie associée et/ou signes de souffrance cutanée
- Trouble sensitifs (perte de sensibilité) en aval de la zone traumatisée.
- Instabilité hémodynamique ou trouble de la vigilance
- Agitation liée à une confusion, une démence, à la consommation de stupéfiant ou d'alcool ; agressivité manifeste.
- Femme enceinte ou se déclarant l'être
- Situation peu claire créant un doute.

# PROTOCOLE DEMANDE ANTICIPEE RADIOGRAPHIE

## Modalités en fonction de la zones anatomiques

**Modalités de demande**



- Localisation
- \+
- Côté
- \+
- Incidence



- ☐ Epaule → *(Face + Profil, +/- Clavicule)*
- ☐ Coude → *(Face + Profil +/- Tête radiale)*
- ☐ Avant-bras → *(Face + Profil)*
- ☐ Poignet → *(Face + Profil +/- incidence scaphoïde)*
- ☐ Main → *(Face + Profil)*
- ☐ Doigts → *(Face + Profil + préciser doigt, phalange P1,P2,P3)*



- ☐ Genou → *(Face + Profil)*
- ☐ Jambe → *(Face + Profil)*
- ☐ Cheville → *(Face + Profil +/- Pied Face + Profil)*
- ☐ Pied → *(Face + Profil)*
- ☐ Orteil → *(Pied Face + Profil)*



- ☐ Bassin → *(Face + Profil)*
- ☐ Hanche → *(Face + Profil)*

Traumatisme **simple** & **isolé**

TRI IOA **VERT**

TRI IOA **ROSE**

*Demande anticipée de radiographie*



*Attention la non prise de paramètres vitaux est seulement applicable au tri vert*

# PROTOCOLE DELIVRANCE D'ANTALGIQUE PAR IOA

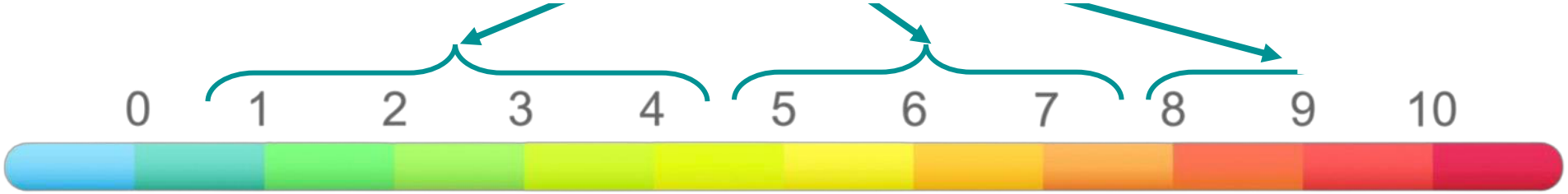
**EVALUATION**

EN (1er intention)

Algoplus® (sujets âgés, non communicants)

EVS, si EN impossible

**MOYEN NON MEDICAMENTEUX (immobilisation, glaçage)**



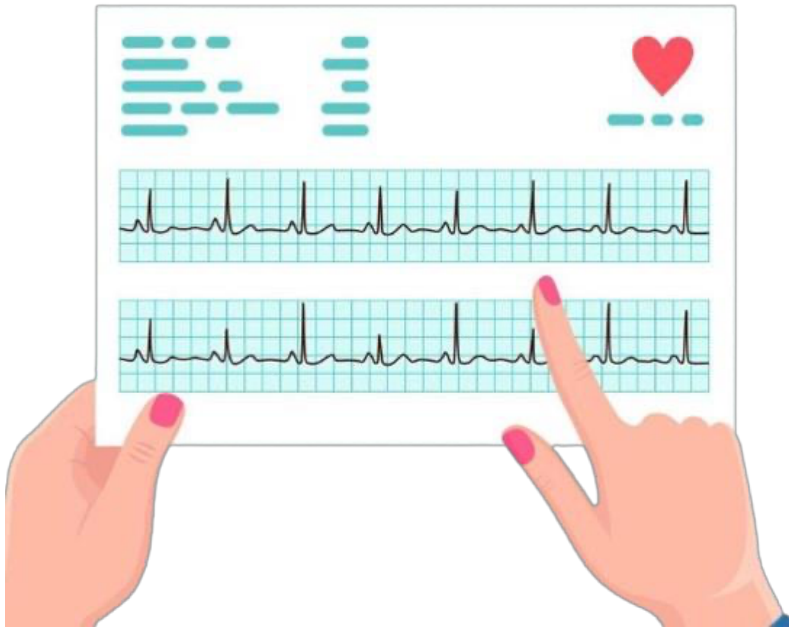

**DOLIPRANE ORO®**
**500MG x 2**

**DOLIPRANE ORO®**
**500MG x 2**
**+**
**ACTISKENAN ORO®**
**10MG**

**DOLIPRANE ORO®**
**500MG x 2**
**+**
**ACTISKENAN ORO®**
**10MG**
**ET / OU**
**TITRATION MORPHINE IV**

**REEVALUATION A 45MIN**

# REALISATION ELECTROCARDIOGRAMME



**DOULEUR THORACIQUE / EPIGASTRIQUE**

**DOULEUR DORSALE (OMOPLATE)**

**DOULEUR EPAULE GAUCHE (SANS TRAUMA)**

**MALAISE**

**ANOMALIE BILAN SANGUIN :**

- **HYPER / HYPOKALIEMIE**
- **TROPONINE AUGMENTEE**

**HYPOTHERMIE**

**FREQUENCE CARDIAQUE < 45 ou > 120**

**ANEMIE < 10g/dL HB + ATCD : IDM / STENT / PONTAGE**

**IMV**

**TRAUMA THORACIQUE (nécessitant d'être allongé)**

**SI INSTALLATION A LA SAUV → PAS D'ECG A L'IOA**